TEMA 32 · Cuidados de enfermería en la adolescencia. Trastornos de la conducta alimentaria. Prevención de hábitos tóxicos

Resumen OPE Enfermería SMS · Pubertad y Tanner, desarrollo psicosocial, entrevista HEEADSSS, PANA, marco legal del menor maduro, nutrición, anorexia, bulimia y atracón (DSM-5), cribado SCOFF, síndrome de realimentación, cuidados en TCA, ESTUDES, CRAFFT, alcohol, vapeo, cannabis, cocaína, hipnosedantes y ciberriesgos

1. Adolescencia

- **OMS: de 10 a 19 años**. Enfoque de **colaboración y confidencialidad**, no paternalista.
- **Primer signo puberal**: en la **niña la telarquia** (botón mamario, **Tanner II**, 8-13 años); en el **niño el aumento del volumen testicular ≥ 4 ml** (Tanner II, 9-14 años; orquidómetro de **Prader**), no el vello púbico.
- **Tanner** (I prepuberal a V adulto): se registran **por separado** mama (S) y vello (P) en la chica (p. ej., **S4-P2**), y genitales (G) y vello (P) en el chico; pueden ir a ritmos distintos.
- **Cerebro**: el **sistema límbico** (emociones, recompensa) madura **antes que la corteza prefrontal** (control de impulsos) → impulsividad y búsqueda de sensaciones. **Piaget**: **operaciones formales** (pensamiento abstracto). **Erikson**: **identidad frente a confusión de roles**; importancia del grupo de iguales.
- **Entrevista HEEADSSS**, de lo neutro a lo íntimo: **H**ogar, **E**ducación/empleo, **E**ating (alimentación), **A**ctividades, **D**rogas, **S**exualidad, **S**uicidio/depresión, **S**eguridad. Explicar al inicio los **límites de la confidencialidad**: se rompe solo ante **riesgo grave para su vida o la de otros** (plan suicida), **maltrato o abuso**. El consumo de cannabis o no usar preservativo **no** justifica avisar a los padres: se interviene con consejo.
- Las **causas externas** (accidentes de tráfico y también el suicidio) encabezan la mortalidad juvenil: prioridad a la educación vial y la salud mental.
- **PANA (Programa de Atención al Niño y al Adolescente, Murcia)**: revisiones en la adolescencia (11, 13-14, 16 años y transición a adultos): somatometría y tensión, **test de Adams** (escoliosis), Tanner, HEEADSSS, visión y audición, cribado de tóxicos, anticoncepción e ITS, vacunas.
- **Vacunas**: **12 años: VPH (chicas y chicos) y MenACWY**; **14 años**: recuerdo de tétanos-difteria (el manual de este tema indica **Tdpa**, para proteger indirectamente a los lactantes de la tos ferina).
- **Marco legal (Ley 41/2002)**:
- **≥ 16 años o emancipado**: **consiente por sí mismo**; no cabe el consentimiento por representación.
- **Menor de 16 «maduro»** (el profesional valora su capacidad): puede consentir; si no es capaz, consienten los padres **tras escuchar su opinión**.
- **Actuación de grave riesgo para su vida o salud** (también con 16-17 años): consiente el **representante legal**, oída la opinión del menor.
- **Ensayos clínicos y reproducción asistida**: **mayoría de edad (18)**.
- **Interrupción voluntaria del embarazo**: con la **LO 1/2023**, las chicas de **16 y 17 años pueden decidir solas**.
- **Nutrición en el estirón** (≈ 50% del peso adulto, 15% de la talla y hasta el 45% de la masa ósea): necesidades según la **velocidad de crecimiento**. **Calcio 1.300 mg/día** (9-18 años, más que el adulto). **Hierro**: **varones 11 mg/día** (aumento de volemia y masa muscular) y **mujeres 15 mg/día** (menstruación). **Cinc** 11 mg (chicos) / 9 mg (chicas).

2. Trastornos de la conducta alimentaria (TCA)

- Origen **multifactorial**: predisponentes (genética, **perfeccionismo**, rigidez), precipitantes (**dietas**, estrés, pubertad) y mantenedores (cambios por la desnutrición). Máxima incidencia en la **adolescencia**.

	Anorexia nerviosa	**Bulimia nerviosa**	**Trastorno por atracón**
Núcleo	**Restricción** con **peso muy bajo**, **miedo a engordar** y **distorsión de la imagen**	**Atracones** + **conductas compensatorias** (vómito, laxantes, ayuno, ejercicio)	**Atracones sin conductas compensatorias**
Frecuencia	—	**≥ 1 vez/semana durante 3 meses**	**≥ 1 vez/semana durante 3 meses**

	Anorexia nerviosa	Bulimia nerviosa	Trastorno por atracón
Peso	Bajo (en adolescentes, IMC < p5 o no gana lo esperado)	**Normal o sobrepeso** (difícil de detectar)	Tiende a la **obesidad**
Gravedad	Por **IMC**: leve ≥ 17; moderada 16-16,99; grave 15-15,99; **extrema < 15**	Por episodios/semana: leve 1-3; moderada 4-7; grave 8-13; extrema ≥ 14	Igual que la bulimia (atracones/semana)

- **DSM-5 eliminó la amenorrea** como criterio de anorexia (puede diagnosticarse con reglas, en varones y antes de la menarquia). **Subtipos** de anorexia (últimos 3 meses): **restrictivo** y **con atracones/purgas**.
- **Signos de anorexia**: **lanugo**, piel seca, acrocianosis, **bradicardia** (< 50), hipotensión, hipotermia, estreñimiento, **amenorrea hipotalámica**, **osteopenia**.
- **Signos de bulimia** (por las purgas): **signo de Russell** (callosidades en el dorso de la mano por provocarse el vómito), **perimólisis** (erosión del esmalte en la cara interna de los dientes), **hipertrofia de parótidas**, esofagitis, **alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasemia** (QT largo, arritmias).
- **Cribado**: **SCOFF** (5 preguntas sí/no: **sentirse lleno**, perder el **control**, **perder > 6 kg en 3 meses**, sentirse **gordo**, la **comida domina la vida**): **≥ 2 síes = sospecha**. **EAT-26**: > 20 puntos = alto riesgo.
- Tratamiento **ambulatorio multidisciplinar** (hospital de día). **Ingreso** si: rechazo total a comer, **IMC muy bajo (< 13)** o pérdida muy rápida, **bradicardia extrema (< 40)**, hipotensión sintomática, arritmias o **QT largo**, **hipotermia**, **alteraciones electrolíticas** (hipopotasemia grave), purgas incontrolables o **riesgo suicida**/psicosis.
- **Síndrome de realimentación** (al renutrir demasiado rápido a un desnutrido grave): la glucosa dispara la **insulina**, que mete en la célula **fósforo, potasio, magnesio** y agua → **hipofosfatemia** (el **dato clave**: fallo muscular, respiratorio y cardíaco), hipopotasemia (arritmias), hipomagnesemia (convulsiones) y déficit de **tiamina** (**encefalopatía de Wernicke**).
- **Alto riesgo** (NICE): IMC < 16, pérdida > 15% en 3-6 meses, ingesta mínima > 10 días o iones bajos antes de empezar.
- Prevención: **«empezar bajo e ir despacio»** (10-15 kcal/kg/día y subir en 4-7 días), **tiamina antes de la glucosa**, suplementar fósforo, potasio y magnesio y **analítica diaria** la primera semana.
- **Cuidados (NANDA)**:
- **Desequilibrio nutricional por defecto**: objetivo de peso pactado con el equipo; **pesar por la mañana, tras orinar, en ropa interior y de espaldas a la báscula**; **acompañar en las comidas y vigilar ≈ 2 h después** (baño supervisado); **restringir el ejercicio**; dieta pautada en 5-6 tomas **sin negociar** la bandeja.
- **Trastorno de la imagen corporal**: separar el aspecto de la **valía personal**; **no hacer comentarios sobre el físico** («te veo mejor», «has cogido peso»): los interpretan como que han engordado.

3. Hábitos tóxicos

- El cerebro adolescente (prefrontal inmaduro y recompensa hiperreactiva) es **más vulnerable a la dependencia**.
- **ESTUDES** (encuesta bienal del Plan Nacional sobre Drogas, 14-18 años): alcohol, tabaco y cannabis en **mínimos históricos**, pero el **alcohol** sigue siendo **la sustancia más consumida** (consumo en **atracón** frecuente); **auge del cigarrillo electrónico/vapeo** (≈ la mitad lo ha probado); preocupan los **hipnosedantes sin receta** y las **apuestas**.
- **Murcia**: **Plan Regional sobre Adicciones 2021-2026**; **programa ARGOS** (prevención desde Atención Primaria con **consejo breve y entrevista motivacional**); programa escolar sobre apuestas «**¿Qué te juegas?**».
- **Cribado: CRAFFT 2.1** (12-21 años; de elección; el **CAGE no sirve** en adolescentes por su baja sensibilidad). Parte A (consumo en 12 meses de alcohol, cannabis u otras); parte B: **C**ar (ir en coche con un conductor colocado), **R**elax, **A**lone, **F**orget, **F**amily/Friends, **T**rouble. **≥ 2 síes = positivo** → intervención breve y derivación. Otros: **AUDIT** (alcohol) y **CAST** (cannabis).
- **Intoxicación etílica**: **posición lateral de seguridad** (aspiración del vómito), **glucemia** (el alcohol bloquea la gluconeogénesis → **hipoglucemia**, no hiperglucemia), **protección térmica** (vasodilatación → **hipotermia**).
- **Vapeo**: no es inocuo: aerosol con nicotina (dependencia), formaldehído, acroleína; riesgo de **EVALI** (lesión pulmonar aguda).
- **Cannabis (THC)**: muy liposoluble; **síndrome amotivacional** (apatía, abulia, fracaso escolar) y **riesgo de psicosis**. **Síndrome de hiperémesis cannabinoide**: vómitos incoercibles que **mejoran con duchas calientes**; los antieméticos fallan; tratamiento: **sueroterapia** y **crema de capsaicina** en el abdomen.

- **Cocaína**: simpaticomimético: agitación, **taquicardia, hipertensión**, **midriasis**, sudoración, **infarto** por vasoespasmo, **parasitosis delirante (Magnan)**.
- **Hipnosedantes (benzodiacepinas)**: depresión del SNC (somnolencia a coma, bradipnea, hipotensión, ataxia). Vía aérea y monitorización; antídoto **flumazenilo**, **contraindicado** en **epilepsia**, **dependencia crónica** de benzodiacepinas o **intoxicación mixta con antidepresivos tricíclicos** (convulsiones). Opioides: **naloxona**.
- **Cuidados**: **confusión aguda** (vía aérea, oxígeno, vía venosa, antídotos, pupilas y Glasgow seriados) y **afrontamiento ineficaz** (identificar desencadenantes y **craving**, alternativas saludables, **entrevista motivacional** sin sermones, las **recaídas forman parte del proceso**).
- **Ciberriesgos**:

Término	Significado
Nomofobia	Angustia por estar **sin el móvil**
Vamping	Usar pantallas **de madrugada**: menos sueño (la luz azul inhibe la **melatonina**), fatiga y fracaso escolar
FOMO	Ansiedad por **perderse** lo que hacen los demás (conexión constante)
Grooming	**Un adulto** se gana la confianza de un menor (a menudo con perfil falso) con fines **sexuales** o de extorsión
Sexting	Envío de **imágenes íntimas propias**; riesgo de **sextorsión**
Ciberbullying	Acoso **entre iguales** por medios digitales

TRAMPAS DE EXAMEN

! Primer signo puberal: **telarquia** (niña) y **volumen testicular ≥ 4 ml** (niño).
! Tanner: mama y vello **por separado**.
! **16 años = consiente solo (salvo grave riesgo, ensayos y reproducción asistida).**
! Confidencialidad: se rompe solo ante **riesgo vital, maltrato o abuso**.
! El **DSM-5 quitó la amenorrea** de la anorexia.
! **Bulimia: alcalosis hipoclorémica e hipopotasemia; signo de Russell.**
! SCOFF **≥ 2**; CRAFFT **≥ 2**; en adolescentes **no CAGE**.
! Realimentación: **hipofosfatemia**; **tiamina antes** de la glucosa.
! Pesar a la paciente **de espaldas** a la báscula; **no comentar su aspecto**.
! Intoxicación etílica: riesgo de **hipoglucemia e hipotermia**.
! Flumazenilo: **nunca con tricíclicos** ni en epilépticos.
! **Grooming** = adulto; **ciberbullying** = iguales.

Imágenes clave del tema



Estadios de Tanner